Erickson

Roberto Franchini

Disabilità, cura educativa e progetto di vita

Tra pedagogia e didattica speciale

3

La riforma del pianeta salute

La riconsiderazione dello status epistemologico della malattia, e comunque della condizione globale delle persona che è nella malattia, è stata oggetto in questi ultimi anni di una revisione radicale anche a opera degli organismi che si occupano di salute, in particolare dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e, per quel che riguarda lo specifico del ritardo mentale, dell'American Association on Mental Retardation. Insieme alla malattia vengono profondamente riesaminati anche i concetti di disabilità e di handicap, che nel passato erano stati considerati unicamente alla stregua di «conseguenze di malattia», in una visione unidirezionale che ha facilitato la loro schematizzazione entro i confini del pregiudizio sanitario, impedendone in gran parte una più autentica comprensione.

Il disagio personale: patologia?

Occorre prima di tutto riflettere intorno alla natura della condizione umana che rende la persona bisognevole di azioni di aiuto: è necessario chiedersi, cioè, se questa possa essere ricondotta univocamente al modello della patologia (il che avvalorerebbe l'approccio sanitario in senso stretto) o se invece debba essere riportata a modelli di natura analogica che, oltre alla malattia intesa come tale, comprendano anche situazioni di più generico impasse personale, lungo una scala o comunque un universo più ampio di complesse disposizioni umane.

Da questo punto di vista non si può non riflettere sulla lezione offerta dai manuali ICIDH (International Classification of Impairment, Diseases and Handicap) e ICF (International Classification of Functioning), pubblicati dall'Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità (OMS) rispettivamente nel 1980 e nel 2002 (OMS, 1980; 2002). Già nel primo manuale l'organismo sovranazionale, coltivando l'ambizione di riassumere ogni tipo di disagio in cui l'uomo può incorrere nel suo percorso di vita, utilizza tre macrotipologie, alle quali riportare con intento ordinatorio le condizioni di danno alla persona: la menomazione o malattia, la disabilità e l'handicap.[46]

La patologia è solo un aspetto, un sottoinsieme del più ampio universo delle problematiche che rendono l'uomo bisognevole di aiuto. Da questa ampia struttura di classificazione si desume immediatamente l'impossibilità di sovrapporre la patologia (malattia o menomazione) alla più generale condizione di disagio personale, confondendo per così dire la parte con il tutto. Come vedremo più avanti, questa impropria e per molti aspetti terribile sineddoche è quella che convince i professionisti dell'aiuto a intervenire sul disagio personale con gli strumenti concettuali tipici della clinica sanitaria, e cioè mediante lo schema semplice e lineare (e forse proprio per questo affascinante) della diagnosi-prognosi, che richiama trattamenti riconducibili alle cosiddette terapie.

Se il sostantivo terapia (o per meglio dire il suffisso, come risulta quando si parla di radioterapia, di chemioterapia, ecc.) è legittimato ogniqualvolta si tratti di curare aspetti patologici, non altrettanto opportuno sembra il suo utilizzo quando chi aiuta rivolge la sua attenzione a problemi di diversa natura, che riguardano la qualità di vita della persona. Non è raro, tuttavia, che interventi con persone in difficoltà rivestano la loro identità in questa direzione, costruendo di volta in volta nuovi segni linguistici quali la ludoterapia se si intende valorizzare il gioco, la danzaterapia se si percorre l'espressione corporea, l'ergoterapia se si rintraccia la funzione riabilitativa del lavoro.

Al di là di altrimenti sterili questioni linguistiche, c'è la sensazione di un effettivo travisamento del significato della relazione di aiuto. Quando si facilita lo sviluppo della persona in aree esistenziali quali il gioco, le attività quotidiane, il lavoro o l'espressione corporea, gli interventi, pur giovando in maniera a volte significativa alle condizioni di salute della persona, costituiscono in realtà la di-

---

46 Dalle iniziali dei tre vocaboli che nella lingua inglese significano i tre appena citati si desume il titolo dello stesso manuale ICIDH, vale a dire International Classification of Impairment, Diseases and Handicap. Nell'edizione italiana la parola *handicap* è tradotta con «svantaggio esistenziale», forse a evitare quel fraintendimento che porta a identificare il termine handicap con ciò che in realtà è disabilità, cioè svantaggio funzionale. Questo fraintendimento è visibile in tutte quelle espressioni nelle quali si accosta il sostantivo handicap ad aggettivi denotanti aree di danno funzionale: pertanto si dice *handicap* motorio, sensoriale e mentale mentre in realtà si dovrebbe dire *disabilità* motoria, sensoriale, ecc., a indicare una mancata funzionalità ad ogni livello.

mensione progettuale e di senso del percorso della persona stessa rientrando in modo ben più decisivo nella questione, mai risolta e definitivamente compiuta, della sua formazione. Non ogni disagio è patologia, o, per dirla in altro modo, non basta essere esenti da patologie per essere in salute. Già nel 1980 la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità affermava che la salute non è semplicemente assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere fisico, psichico, sociale e relazionale. Ecco allora il motivo per il quale il manuale ICIDH, a lato e sullo stesso piano delle condizioni patologiche, esamina e classifica situazioni umane riconducibili alle categorie della disabilità, intesa quale danno funzionale, e dell'handicap, inteso quale svantaggio sociale ed esistenziale.

Che cos'è la disabilità

Esaminiamo allora ciò che per definizione sfugge alle maglie strette della diagnosi patologica. La disabilità, nel sistema ICIDH, deve essere compresa quale assenza o compromissione di una qualsiasi abilità, ma in particolare di quelle abilità che si esercitano nel campo esteso delle attività ritenute normali per l'individuo in ogni situazione di vita (prestazioni cognitive, motorie e sensoriali, ma ancora attività complesse quali l'accudimento della persona — igiene, abbigliamento, alimentazione — e della casa, oltre che il lavoro, la comunicazione interpersonale, ecc.).

A questo proposito, tuttavia, il manuale del 1980 non sfugge a una certa rigidità concettuale, presupponendo che a fondamento e causa della situazione di disabilità ci sia nuovamente la patologia, la quale pertanto rischia nuovamente di essere intesa quale unica sorgente, anche se non unica condizione, di disagio personale. Questa impostazione è visibile, oltre che nel testo delle singole definizioni,[47] anche nel diagramma esplicativo dell'architettura di classificazione, riportato in figura 3.1.

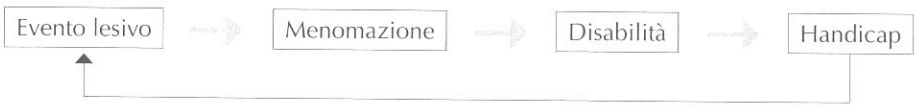

Fig. 3.1 Diagramma esplicativo dell'architettura di classificazione delle disabilità secondo il sistema ICDH.

[47] La disabilità viene definita come «limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di effettuare una attività, nel modo o nei limiti considerati normali per un essere umano», e ancora come «oggettivazione della menomazione».

Dalla semplice e lineare consequenzialità delle situazioni di danno si deduce una eziologia a senso unico: è comunque sempre la patologia la causa del disagio! Dunque, se davvero si vuole incidere sul disagio stesso, occorre intervenire con gli strumenti tradizionali volti a limitare o a «guarire» la patologia, e cioè la diagnosi e la terapia. Torna allora il predominio dell'ottica sanitaria, o per meglio dire sanitarista, ed è chiaro che non di naturale solidarietà si tratta quando si decide di aiutare la persona, ma di intervento esperto, che solo il professionista clinico, in ultima analisi, può agire in completezza. Ma è proprio così? Davvero l'impossibilità o comunque la difficoltà che la persona può sperimentare nell'esercitare le normali azioni della vita quotidiana, quali il comunicare, il ragionare e il muoversi, il mangiare, il vestirsi e lo scrivere, dipende univocamente e presuntivamente da un danno di natura patologica? Non ci sembra che questo sia sostenibile: quante e quali situazioni, emozioni o convinzioni irrazionali possono in realtà limitare l'uomo nell'agire, bloccando e inibendo la sua iniziativa e la sua libertà personale.

Sono infatti potenzialmente infiniti i fattori che possono ostacolare l'individuo nello sviluppo della sua personalità, limitando le sue capacità di modificare continuamente (e progettualmente) l'assetto complessivo del proprio essere-nel-mondo, e creando con ciò stesso disabilità. È chiaro allora che, se in molti casi la causa di un danno funzionale è la realtà sovente statica (cronica!) di una patologia, in molte altre situazioni, invece, all'origine dello svantaggio vi è un insieme dinamico di mancati sviluppi, interrotte evoluzioni, distorti cambiamenti, tali da richiamare e postulare non l'intervento specializzato del professionista clinico, ma la progettualità pedagogica della comunità educante.

Menomazione, disabilità, handicap: se il superamento dell'eziologia clinica è sostenibile, almeno in qualche misura, per le molteplici condizioni di disabilità, esso è importante e decisivo per tentare di capire veramente che cosa significhi handicap, inteso quale svantaggio esistenziale. Anzi, si può persino affermare che il predominio dell'ottica clinica ha di fatto impedito un'autentica comprensione della situazione esistenziale di handicap.

Per comprendere questa affermazione, dal tono inequivocabilmente perentorio, ripartiamo ancora una volta da un tentativo di definizione, poggiato sul solido fondamento del manuale ICIDH: l'handicap è da intendersi quale svantaggio sociale, che limita o impedisce alla persona lo svolgimento di un ruolo ritenuto normale nel contesto socioculturale cui di fatto appartiene nella concretezza del vivere quotidiano. Ogni persona, infatti, costruisce la sua esistenza intorno a uno o più ruoli sociali, che disegnano (o non disegnano) la sensatezza e la compiutezza del proprio progetto di vita, la ricchezza delle opportunità di fare e agire. Ad esempio l'individuo riesce ad attingere equilibrio e serenità interiore in quanto esercita il ruolo di sposo, sposa, padre, madre, lavoratore e ogni altra

funzione attraverso la quale possa attivare e mantenere viva la propria struttura trascendentale (esistenziale, direbbe Heidegger) dell'essere-nel-mondo, come anche (e forse più) dell'essere-in-relazione.

Non è cosa di poco conto che l'OMS consideri alla stregua di un grave svantaggio, paragonabile a quello rappresentato dalla patologia, o comunque dalla disabilità, il mancato o limitato perseguimento del progetto personale, identificato mediante il concetto di ruolo e indagato nella dinamica interazione tra ciò che l'individuo riesce a essere e ciò che la società continuamente gli chiede di diventare.

Spiace solamente che all'interno del manuale del 1980 la situazione di handicap sia ritenuta ancora una volta rigidamente consequenziale rispetto alla malattia,[48] non considerando che lo svantaggio sociale, inteso come esclusione ed emarginazione, anche qualora sia complicato dalla presenza di una patologia, si gioca in realtà molto più nei percorsi evolutivi e nelle dinamiche relazionali tra individuo e individuo (e tra individuo e società) piuttosto che nel limitato schema causale di una diagnosi clinica. Allo stesso tempo, pertanto, l'handicap è molto più una questione educativa (o anti-educativa; una sfida per l'educazione, si potrebbe dire) piuttosto che una problematica clinica e riabilitativa.

Riassumendo, in modo forse un po' semplicistico, quanto detto finora, potremmo dire che se la patologia richiede la forma clinica della relazione di aiuto, e la disabilità quella abilitativa, l'handicap si pone come una questione educativa,[49] affrancandosi una volta per tutte dallo stereotipo della cura sanitaria (figura 3.2): non si tratta di intervenire su un malato, ma di liberare le energie progettuali di un individuo in situazione di handicap, consentendogli di costruire la propria storia, al di là e oltre ogni danno dal quale egli possa essere afflitto.

Fig. 3.2 Le tre dimensioni costitutive dell'aiuto alla persona.

[48] L'handicap è definito come «situazione di svantaggio sociale, conseguente a menomazione e/o disabilità, che limita o impedisce l'adempimento di un ruolo normale per un dato individuo in funzione di età, sesso e fattori culturali e sociali», e ancora come «la socializzazione di una menomazione o di una disabilità».

[49] *Treatment is education,* afferma lo psichiatra Schopler, come vedremo più avanti.

L'evoluzione dal sistema di classificazione ICIDH al sistema ICF sottolinea ulteriormente questo allargamento di orizzonte, ribaltando in positivo i focus intorno ai quali si centra l'intento classificatorio. Come si può vedere in figura 3.3, i termini negativi, che indicavano il danno alla persona, scompaiono, lasciando il posto a componenti neutre, delle quali occorre misurare il funzionamento: alla menomazione, pertanto, si sostituiscono la funzionalità e la struttura corporea, alla disabilità il grado di attività, all'handicap la partecipazione sociale, in una visione promozionale e «formativa» della salute dell'uomo.

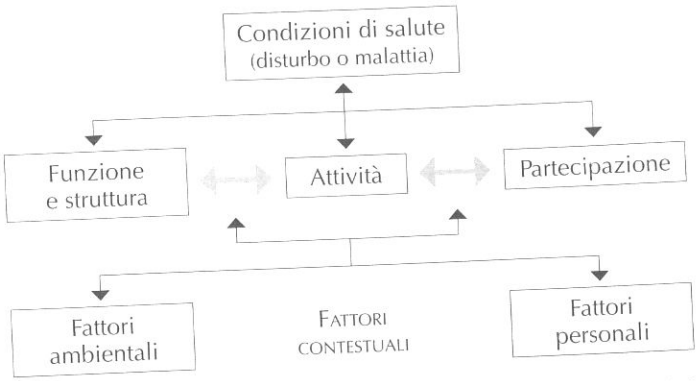

Fig. 3.3 Diagramma esplicativo dell'architettura di classificazione della disabilità secondo il sistema ICF.

La disabilità viene ora intesa come un termine ombrello, pertanto non utilizzabile in senso specifico, ma genericamente spendibile per indicare ogni menomazione e/o limitazione delle attività, o, ancora, una restrizione della partecipazione sociale, connotando pertanto l'aspetto negativo dell'interazione tra un individuo e i fattori contestuali dello stesso individuo. Inoltre il sistema ICF non dimentica di considerare, all'interno dello schema di classificazione (e di conseguenza nell'intenzionalità di presa in carico e di miglioramento), i fattori ambientali e personali, in un approccio che giustamente è stato considerato di natura ecologica (Cavagnola, 2000).

La concezione semplice, per così dire digitale, del concetto di salute viene superata da una concezione complessa, qualitativa, analogica e multidimensionale. Allo schema clinico, che interpreta il concetto di salute come un costrutto di natura digitale (vale a dire salute-sì/salute-no: o si è in salute per una completa assenza di malattia, o non lo si è, per la presenza di una o più patologie), si sostituisce una concezione funzionale, dove il concetto di salute si trasforma nel più completo

paradigma di «benessere»,[50] cioè di «qualità di vita». Allora non si tratta di essere o non essere in salute, ma di evolvere in modo continuo (analogico!) da un livello all'altro di benessere e qualità di vita, in un'opera senza fine che risulta affine, per dinamica e prospettiva, alla logica educativa.

Non è soltanto la guarigione che interessa, dunque, ma il livello di ben-essere della persona, che può e deve essere aumentato, attraverso l'iniziativa personale e l'aiuto solidale di altre persone, che sostengono e agevolano lo sviluppo dell'iniziativa e della partecipazione di ogni individuo nel più ampio contesto della comunità umana. Allora non ha più significato affermare che un uomo è sano o malato, e solo nel secondo caso intervenire: occorre invece di volta in volta esplorare, in ogni età e in ogni condizione di vita, quale sia il livello ulteriore di salute possibile e auspicabile, certamente in termini di funzionalità corporea, ma anche in ordine a un più ampio ed equilibrato progetto personale di attività e di partecipazione sociale: in termini di auto ed etero-educazione, dunque.

In questo orizzonte la rigida schematicità del ragionamento *per causam* sfuma, finalmente, all'interno di un continuo e circolare gioco di rimandi: la partecipazione sociale è funzione delle attività, ma queste a loro volta dipendono e rinviano alla funzionalità corporea, la quale risente degli influssi degli stili e degli ambienti di vita, e così via, circolarmente. Salta allora lo schema semplice della diagnosi eziologica, e si avverte l'esigenza di paradigmi valutativi inediti, che possono trarre dalle scienze umane, e in particolare dalla pedagogia, l'attitudine a osservare e interpretare un vasto complesso di segni e comportamenti, a fondamento di autentici ed efficaci interventi per il miglioramento della salute dell'uomo.

Profondamente affine al sistema ICF, nel 2002 l'AAMR pubblica la X edizione del sistema di definizione e classificazione del ritardo mentale (AAMR, 2005). Pur essendo un sistema specifico per il ritardo mentale, il manuale prosegue nell'itinerario verso una concezione rinnovata del termine «disabilità», alla luce non più della malattia e delle sue prevedibili conseguenze, ma del funzionamento della persona entro il suo ambiente di vita: la disabilità viene infatti definita come «l'espressione di limitazioni nel funzionamento individuale all'interno di un contesto sociale; [...] rappresenta uno svantaggio sostanziale per la persona».

Come si può vedere in figura 3.4, la disabilità è considerata come la risultante complessa di cinque dimensioni (capacità intellettive, comportamento adattivo, partecipazione/interazione/ruoli sociali, salute e contesto), che influiscono sul funzionamento della persona in modo non univoco, al punto che in ogni persona

[50] L'ICF con il termine *benessere*, ritenuto più ampio e significativo del termine *salute*, intende racchiudere tutto l'universo dei domini della vita umana, inclusi aspetti fisici, mentali e sociali, che costituiscono quella che può essere chiamata una «buona vita».